SDD 185 Sujet n°1

Spécialité : Cardiologie

Date : 08/02/2024
Auteur : Séverine DOMART
Relecteur(s) : ELAYLI Robin (DES Psychiatrie, ECN 2023), Lucie-Lou VIAL (DES MAR, EN 2023)

Domaine d'apprentissage principal	Iconographie
Domaine d'apprentissage secondaire	Stratégie de prise en charge
Item(s) en lien avec la station	ITEM 230 Fibrillation atriale
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 185 Interprétation de prise en charge
Matériel nécessaire à la station	1 bureau 2 chaises ECG fourni avec le sujet
Contexte de la station	Mme. G, 80 ans, venue en HDJ endocrinologique pour le suivi de son diabète de type 2, présente une anomalie à l'ECG.

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes interne de médecine générale aux urgences, et vous êtes appelé dans les étages pour Mme G, 80 ans, venue aujourd'hui en endocrinologie pour le suivi de son diabète de type 2.

A l'interrogatoire, l'interne d'endocrinologie vous décrit que la patiente se rappelle avoir ressenti des palpitations depuis quelques semaines. Elle est suivie par un cardiologue pour son hypertension. Sa dernière échographie cardiaque retrouvait une FEVG préservée, sans autre anomalie.

Son bilan biologique du jour est sans anomalie.

Les constantes sont : une tension à 145/89 mmHg, FC 142 bpm, sat 98% en air ambiant. Elle ne présente aucun signe clinique.

Consignes :
Vous avez 8 minutes pour :

- Analyser l'ECG
- Proposer et justifier votre prise en charge médicamenteuse précise et ses objectifs

Vous ne devez pas :

- Réaliser un examen clinique
- Faire un interrogatoire
- Rédiger une ordonnance
- Orienter la patiente pour la suite de sa prise en charge
- Rechercher une étiologie à l'anomalie mise en évidence

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station sans patient standardisé.

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)		
Iconographie		
1.	Décrit un ECG 12 dérivations	1 pt
2.	Énonce un rythme non sinusal ou irrégulier	1 pt
3.	Préciser la FC : environ 140 (entre 125-175 bpm)	1 pt
4.	Préciser l'axe du coeur : gauche	1 pt
5.	Décrire le QRS : fin	1 pt
6.	Décrire la repolarisation : pas de trouble de la repolarisation (mais interprétation limitée dans un contexte de fibrillation atriale)	1 pt
7.	Décrire la présence d'une extrasystole ventriculaire	1 pt
8.	Reconnaît une fibrillation atriale (pas de point si dit FA sans expliciter)	1 pt
Stratégie de prise en charge		
9.	Propose un traitement ralentisseur : bêta-bloquant	1 pt
10.	Explique que les bêta bloquants ont pour rôle de ralentir la fréquence cardiaque	1 pt
11.	Dit utiliser le score de CHAD-VASC	1 pt
12.	Donne la valeur calculée du score CHAD-VASC de la patiente (5)	1 pt
13.	Dit qu'il a une indication à anticoaguler	1 pt
14.	Propose un anticoagulant oral direct	1 pt
15.	Explique que l'intérêt principal de l'anticoagulation est de prévenir les complications thromboemboliques OU de prévenir un risque d'AVC	1 pt
Communications et attitudes (ICI) (max 5 grilles)		

<table>
<tr><td>1.</td><td>

8. APTITUDE À FAIRE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES

<table>
<tr><th>Performance Insuffisante

0 point</th><th>Performance Limite

0,25 point</th><th>Performance Satisfaisante

0,5 point</th><th>Performance Très Satisfaisante

0,75 point</th><th>Performance Remarquable

1 point</th></tr>
<tr><td>N'arrive pas à faire ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème</td><td>Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème quelquefois sans les justifier</td><td>Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème et justifie son raisonnement</td><td>Fait ressortir les éléments positifs et négatifs pour clarifier le problème et justifie son raisonnement</td><td>Agit avec assurance et sans erreur</td></tr>
</table>

</td><td>1 pt</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>

12. APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE (situations aiguës / chroniques)

<table>
<tr><th>Performance Insuffisante

0 point</th><th>Performance Limite

0,25 point</th><th>Performance Satisfaisante

0,5 point</th><th>Performance Très Satisfaisante

0,75 point</th><th>Performance Remarquable

1 point</th></tr>
<tr><td>Est incapable de proposer une prise charge adaptée à la situation clinique</td><td>Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels, n'arrive pas à justifier la démarche</td><td>Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels et justifie la démarche.</td><td>Propose une prise pertinente. Ne s'attarde pas au traitement/prise en charge inutile et justifie la démarche.</td><td>Etablit l'ordre de priorité des différents aspects de la prise en charge du patient (hiérarchise).</td></tr>
</table>

</td><td>1 pt</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL (max 20 items)</td><td>…/ 16 points</td></tr>
</table>

<u>Éléments de rétroaction :</u> (facultatif)

Dans cette partie vous pouvez indiquer des éléments qui vous semblent importants à signaler aux étudiants qui s'entraînent sur votre station (Élément inacceptable, comment raisonner face à votre station, autre conseil…).

ECOS TACFA
SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Vous êtes l'interne d'endocrinologie qui décrit la situation de sa patiente au cardiologue qui donne les avis.

Mme G, 80 ans, est venue aujourd'hui en HDJ d'endocrinologie pour le suivi de son diabète de type 2. Elle présente une anomalie à l'ECG réalisé de manière systématique, non retrouvée lors de son dernier ECG.

La patiente se rappelle avoir ressenti des palpitations depuis quelques semaines. La patiente a pour antécédents un diabète de type 2, une HTA, une dyslipidémie. Elle n'a pas d'autres comorbidité. Elle est suivie par un cardiologue pour son hypertension. Sa dernière échographie cardiaque retrouvait une FEVG préservée, sans autre anomalie.

Son bilan biologique est sans anomalie. Pas de perturbation ionique, ni insuffisance rénale, ni perturbation du bilan hépatique.

Cliniquement, elle a une tension à 145/89 mmHg, FC 140 bpm, sat 98% en air ambiant. Elle n'a pas de signe d'hypoperfusion. Elle n'a pas de signe d'insuffisance cardiaque. Elle n'est pas dyspnéique, n'a pas d'angor.

Plan de la station ECOS :

<u>Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :</u>

Bonjour,
Je vous appelle pour prendre un avis sur un ECG pour une de mes patientes

Identité du patient :

Mme. G, 80 ans, Femme
1m67, 72 kg

Mode de vie :

Retraitée, travaille dans une usine
Mariée, 2 enfants
Pas d'alcool, ni de tabac, ni de drogue
Pratique du sport au quotidien
Vit dans une maison

Comportement global :

Vous êtes l'interne au téléphone et communiquez avec des termes médicaux

Antécédents personnels :

DT2
Dyslipidémie
HTA

Antécédents familiaux :

RAS

Médicaments :

Bien distinguer le traitement de fond (= habituels) des traitements pris récemment dans le cadre de la situation clinique (ex prise de PARACETAMOL pour soulager les douleurs)

Metformine Valsartan

Symptômes positifs :

Se mettre à la place des patients simulés au maximum.

Pensez au biais de la simulation (le patient simulé n'est pas malade)

Pensez à la chronologie des réponses du patient simulés en fonction de la grille d'évaluation en regard → Si la grille donne 1 point pour la recherche de la localisation de la douleur et 1 point pour le type de la douleur, il faut bien indiquer au patient simulé de répondre uniquement à ce qui lui est demandé et non tout le script

Ex de rédaction :

- *Si l'étudiant demande si le patient a une douleur → "Que souhaitez-vous savoir sur ma douleur".*
- *SI l'étudiant demande où se situe de la douleur → "Elle est dans le bas du ventre à droite"*
- *Si l'étudiant demande le type douleur → "ça brûle"*

Ne pas hésiter à mettre de schéma des signes physiques à mimer

Palpitations Pas d'essouflement Pas de douleur à la poitrine Jambes non gonflées

Constantes :

TA 145/89 mmHg, FC 142 bpm, sat 98%

Donnée complémentaire :

Ex : (Photo, courrier, résultat d'examen complémentaire), les dater (ce jour, il y a une semaine, un mois etc)

Nb : Préciser la chronologie indiquant quand les remettre au candidat

NE PAS OUBLIER DE METTRE LE DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE SUR LE DRIVE

Questions de relance :

Nb : Préciser au candidat quand celui-ci doit les énoncer.

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Plan de la station ECOS :

Où se positionne le/les patients, étudiant, le matériel

Matériel nécessaire à la station :

- *IPAD pour examinateur*
- *Feuille de brouillon pour candidat*
- *Stylo pour candidat*
- *Feuille de brouillon pour évaluateur*
- *Stylo pour évaluateur*

Documents présents dans la station :

- *Feuilles d'évaluation de papier de secours*